

SÍNDROME DEPRESIVO

C.M. Franch Pato, V. Ámez Cepeda, R. Gómez Martínez.

INTRODUCCIÓN

Los síntomas depresivos constituyen unos de los motivos más frecuentes de consulta en la urgencia, bien como primera consulta, bien como recaídas o para ajuste de medicación. La queja del paciente puede ser directamente el ánimo depresivo o pensamientos/actos autolíticos, o presentarse con sintomatología depresiva enmascarada por somatizaciones o alteraciones conductuales.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico principal de un síndrome depresivo en el Servicio de Urgencias se hace a través de una anamnesis detallada, existiendo tres síntomas fundamentales en los trastornos depresivos:

- Ánimo decaído
- Anhedonía: incapacidad para disfrutar de las actividades que normalmente nos son placenteras
- Anergia: falta de energía

Además, pueden existir otra serie de síntomas como son:

- Alteraciones en ritmos biológicos (apetito/sueño)
- Alteraciones en esfera sexual
- Alteraciones conductuales
- Quejas somáticas
- Quejas cognitivas

Es importante recoger, además de la sintomatología actual, la historia anterior y el curso longitudinal del trastorno afectivo, así como los tratamientos previos y la respuesta y tolerancia a ellos y la presencia de factores precipitantes del episodio actual.

En la exploración se deberán valorar, además, las cogniciones en torno a la muerte, debiendo distinguir entre los deseos de morir o estar muerto de la ideación propiamente autolítica, de mayor gravedad aún si incluso ha llegado a planificar su propia muerte.

Diagnóstico diferencial

Es importante descartar los trastornos orgánicos en pacientes que refieren sintomatología depresiva de reciente aparición, ya que algunos de los síntomas propios de la depresión (anergia, anorexia, pérdida de peso, astenia) pueden deberse a enfermedades orgánicas, como por ejemplo las que se muestran en la siguiente tabla:

Sustancias Psicoactivas	Anfetaminas y simpaticomiméticos relacionados Alucinógenos
Medicaciones	Corticoesteroides Levodopa Antihipertensivos de acción central Cicloserina Estrógenos Clomifeno

Sustancias Psicoactivas	Anfetaminas y simpaticomiméticos relacionados Alucinógenos
Trastornos Endocrinos	Hipotiroidismo, hipertiroidismo Enfermedad de Addison Síndrome de Cushing Hipoglucemia, Diabetes Mellitus Hiperparatiroidismo Hipopituitarismo
Otros Trastornos Sistémicos	Anemia perniciosa Insuficiencia hepática Insuficiencia renal Artritis reumatoide Lupus eritematoso sistémico Neoplasias (especialmente ca. páncreas, síndrome carcinoide) Infecciones víricas (gripe, neumonía, mononucleosis, hepatitis)
Causas Intracraneales	Tumores cerebrales TCE Enfermedad de Parkinson Infecciones (neurosífilis) Procesos demenciales incipientes

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una vez realizado el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico diferencial se plantea la cuestión de iniciar o no un tratamiento antidepresivo en el Servicio de Urgencias.

Si el paciente presenta una depresión moderada-leve, será valorado en un plazo breve por otro profesional, que se hará cargo de su tratamiento continuado, por lo que si no disponemos datos de respuesta a tratamientos previos, lo más recomendable es no iniciar en ese momento un tratamiento antidepresivo y que sea su médico de atención primaria o psiquiatra de referencia quien lo inicie, pautando mientras tanto ansiolíticos en caso de que sea preciso.

Si existen antecedentes de buena respuesta en episodios anteriores a un antidepresivo, o en caso de que no pueda ser valorado en corto plazo por otro profesional, lo más adecuado será iniciar el tratamiento antidepresivo. La elección se hará en función de respuestas previas, tolerancias, interacciones farmacológicas, clínica del paciente, recomendando iniciar con un ISRS junto con un ansiolítico.

Si ya se encuentra tomando un antidepresivo, con buena tolerancia, pero respuesta insuficiente, puede aumentarse la dosis de este, dejando la decisión de cambio de antidepresivo o asociación de otro a su especialista habitual.

Si el paciente presenta sintomatología depresiva grave, deberá avisarse al especialista, ocurriendo esto en los siguientes casos:

- El principal criterio de ingreso de un paciente depresivo es el riesgo de suicidio, lo que hace necesaria la valoración por parte del especialista, debiendo explorarse sistemáticamente en todo paciente depresivo. Hay que preguntar por la presencia de deseos de muerte, ideación, planes o intentos autolíticos.
- Clínica depresiva mayor, con tristeza vital, arreactividad, empeoramiento matutino, anhedonia total, inhibición o agitación psicomotriz intensa
- La presencia de ideas delirantes, tanto congruentes (culpa, ruina) como incongruentes con el

estado del ánimo

- Las dudas diagnósticas
- La resistencia al tratamiento
- La existencia previa de un diagnóstico de Trastorno Bipolar

Valoración del riesgo de suicidio

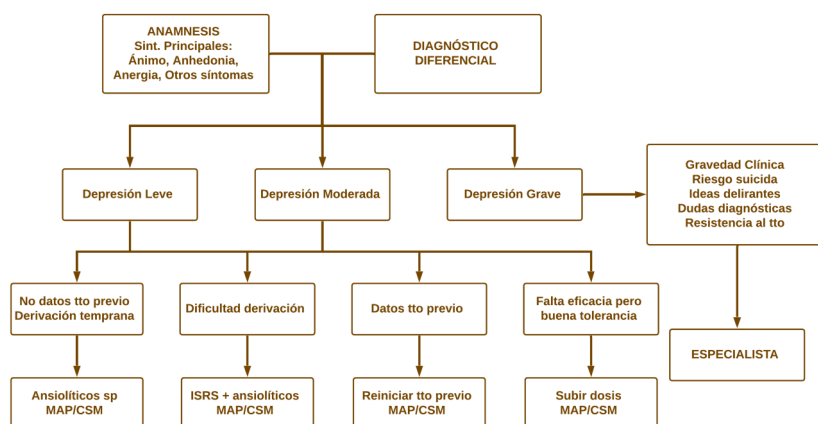
Existen varias escalas, una de las mas prácticas es la escala de **SAD PERSONS**.

ÍTEMS	SI	NO
• S: Sexo masculino		
• A: Edad < 20 o > 45 años		
• D: Depresión		
• P: Previous attempt (intentos previos de suicidio)		
• E: Ethanol abuse (abuso de alcohol)		
• R: Rational thinking loss (psicosis o trastornos cognitivos)		
• S: Social supports lacking (sin apoyo social)		
• O: Organized plan (plan organizado de suicidio)		
• N: No spouse (sin pareja estable)		
• S: Sickness (enfermedad somática)		

Cada ítems da una puntuación de uno, siendo 10 su máxima puntuación.

- **0-2 puntos:** sin riesgo. Alta con seguimiento ambulatorio.
- **3-4 puntos:** bajo riesgo. Seguimiento ambulatorio intenso, considerar ingresar
- **5-6 puntos:** riesgo medio. Si no hay apoyo familiar estrecho debe ingresar
- **7-10 puntos:** riesgo alto. Ingreso. Riesgo de intento inminente.

Algoritmo de Actuación



BIBLIOGRAFÍA

- Cebollada Gracia A., Blasco Fontecilla H. El paciente afectivo. En: Chinchilla A. Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson S.A.; 2003. p. 191-219
- Síntomas y síndromes psiquiátricos presentados como urgencias. En: Puri B.K, Treasaden I.H. Urgencias de psiquiatría. Madrid: Grupo Aula Médica S.L.; 2009. p. 51-66